

La boca como espejo del cuerpo

Un recorrido ilustrado por las enfermedades sistémicas que dejan huella —a veces la primera huella visible— dentro de la cavidad oral.

Artículo de revisión y divulgación clínica Manifestaciones orales de enfermedades sistémicas

La exploración de la cavidad oral puede revelar cambios asociados con enfermedades endocrinas, hematológicas, inmunológicas, gastrointestinales, infecciosas y nutricionales. Este texto reúne los contenidos de la publicación web de referencia y conserva su estructura temática, imágenes y 22 referencias bibliográficas.

Fuente principal del contenido: articulo-manifestaciones-orales.vercel.app

Introducción

La cavidad oral es, en palabras de numerosos autores, la «ventana del cuerpo»: un lugar de fácil observación clínica donde múltiples enfermedades que afectan a órganos distantes —el sistema endocrino, la sangre, el intestino, el sistema inmunitario— dejan signos visibles antes incluso de que aparezcan otros síntomas. Reconocer estos signos puede acelerar diagnósticos, y en algunos casos salvar vidas.¹

Este artículo reúne, con fines educativos, ejemplos de enfermedades sistémicas con manifestaciones orales características, cada una acompañada de una fotografía clínica real —de licencia libre en Wikimedia Commons o, cuando fue necesario, cedida por publicaciones médicas especializadas y citada con su fuente— y de referencias a artículos científicos y clínicos verificables.

El objetivo no es sustituir el criterio clínico, sino mostrar, con evidencia visual y bibliográfica, por qué una exploración bucal cuidadosa puede ser una herramienta de cribado temprano tan valiosa como cualquier análisis de laboratorio.

01 · ENDOCRINO · METABÓLICO

Diabetes mellitus

Enfermedad periodontal, xerostomía y lengua geográfica

La diabetes mal controlada favorece la enfermedad periodontal, la sequedad bucal (xerostomía) y una mayor susceptibilidad a infecciones por *Candida*. También se ha descrito una asociación —aunque no siempre confirmada estadísticamente— entre la diabetes tipo 1 y la lengua geográfica (glositis migratoria benigna), una condición inflamatoria que produce zonas rojizas de descamación en el dorso lingual, de bordes blanquecinos y forma cambiante.²

La periodontitis y la diabetes tienen además una relación bidireccional bien documentada: la inflamación periodontal crónica puede dificultar el control glucémico, y la hiperglucemia mantenida agrava la destrucción del tejido de soporte dental.³



Lengua geográfica (glositis migratoria benigna). Foto: Wikimedia Commons, dominio público / uso libre.

02 · HEMATOLOGÍA

Anemia ferropénica

Queilitis angular y glositis atrófica

El déficit de hierro (y, en menor medida, de vitamina B12 o ácido fólico) puede manifestarse en la boca como queilitis angular —fisuras, eritema y descamación en las comisuras labiales— y como glositis atrófica, con pérdida de las papilas linguales y una lengua lisa y pálida o dolorosa. En su forma más clásica, la combinación de anemia ferropénica, glositis y disfagia por membranas esofágicas se conoce como síndrome de Plummer-Vinson.⁴



Queilitis angular bilateral, hallazgo asociado a anemia ferropénica. Foto: Matthew Ferguson, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

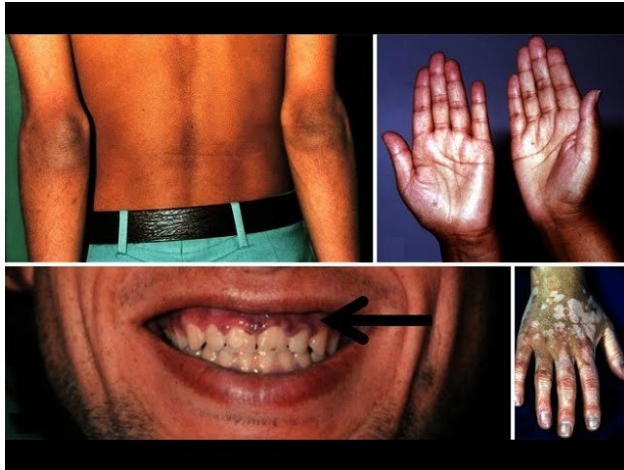
03 · ENDOCRINO

Enfermedad de Addison

Pigmentación mucosa difusa

La insuficiencia suprarrenal primaria eleva la hormona ACTH, que estimula a los melanocitos y produce una hiperpigmentación cutánea y mucosa característica. En hasta el 92% de los pacientes esta pigmentación aparece en la mucosa yugal, las encías, el paladar, la lengua y el borde bermellón de los labios, y con frecuencia precede en meses o años a los demás síntomas (fatiga, hipotensión, pérdida de peso), lo que convierte a la exploración bucal en una herramienta

diagnóstica temprana.^{5,6}



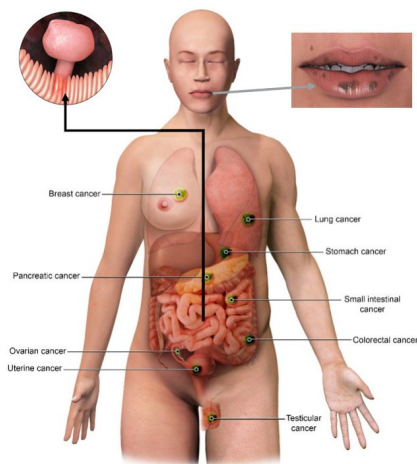
Manifestaciones mucocutáneas de la enfermedad de Addison. Imagen aportada para el artículo; fuente clínica de referencia indicada en la publicación web.

04 • GENÉTICA • GASTROINTESTINAL

Síndrome de Peutz-Jeghers

Máculas melanóticas periorales

Este trastorno autosómico dominante, causado por mutaciones en el gen *STK11/LKB1*, asocia pólipos hamartomatosos gastrointestinales con manchas pigmentadas de color marrón oscuro a azul-negruzco alrededor de la boca, en la mucosa bucal y en dedos de manos y pies. Estas máculas suelen aparecer en la infancia, cruzan el borde del labio —a diferencia de las simples pecas— y en más del 95% de los casos se localizan en la región perioral.⁷



Manifestaciones mucocutáneas del síndrome de Peutz-Jeghers. Foto: Wikimedia Commons.

05 • PEDIATRÍA • VASCULITIS

Enfermedad de Kawasaki

Lengua «en fresa» y labios fisurados

Esta vasculitis febril de la infancia se diagnostica clínicamente, y sus criterios incluyen cambios muy visibles en labios y cavidad oral: labios rojos, secos y agrietados, y una lengua «en fresa» —papilas fungiformes hipertróficas sobre un fondo eritematoso— casi indistinguible de la que

aparece en la escarlatina o el síndrome del shock tóxico, con las que forma parte del diagnóstico diferencial.⁸



(A) Inyección conjuntival bilateral. (B) Lengua «en fresa» y labios rojos, secos y fisurados. Foto: Wikimedia Commons.

06 • NUTRICIÓN

Escorbuto

Déficit de vitamina C

La vitamina C es indispensable para la síntesis de colágeno. Su carencia grave produce encías edematosas, esponjosas, de color rojo-púrpura y con sangrado espontáneo, además de movilidad y pérdida dental. Aunque hoy se asocia sobre todo a desnutrición severa, alcoholismo o dietas extremadamente restrictivas, sigue documentándose en la práctica clínica actual.⁹



Encías escorbúticas: edema, coloración rojo-violácea y sangrado. Foto: Wikimedia Commons.

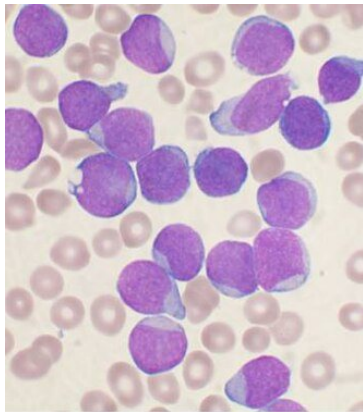
07 • INFECTOLOGÍA

Infección por VIH/sida

Candidiasis oral, leucoplasia vellosa y sarcoma de Kaposi

La inmunosupresión asociada al VIH favorece tres hallazgos orales clásicos: la candidiasis pseudomembranosa (placas blanquecinas desprendibles sobre la mucosa), la leucoplasia vellosa (placas blancas corrugadas e irregulares en los bordes laterales de la lengua, causadas por el virus de Epstein-Barr y que, a diferencia de la candidiasis, no se desprenden al raspado) y el sarcoma de

Kaposi, un tumor vascular asociado al herpesvirus humano 8 que aparece como placas o nódulos rojo-violáceos, típicamente en el paladar duro y la encía.^{10,11}



Candidiasis pseudomembranosa oral («muguet»). Foto: CDC Public Health Image Library, dominio público, vía Wikimedia Commons.



Manifestación clínica oral asociada a infección por VIH/sida. Foto: material aportado para el artículo.

08 · DERMATOLOGÍA · AUTOINMUNE

Liquen plano oral

Estrías de Wickham

El liquen plano oral es un trastorno inflamatorio mediado por linfocitos T que afecta la mucosa bucal, con una prevalencia estimada del 0,5-2% de la población. Su forma más frecuente, la reticular, se presenta como finas líneas blancas entrelazadas (estrías de Wickham) en la mucosa yugal, habitualmente asintomáticas; la forma erosiva, en cambio, cursa con áreas rojas dolorosas y úlceras.

La Organización Mundial de la Salud lo clasifica como una condición potencialmente maligna, con un riesgo de transformación a carcinoma oral de escamosas de hasta el 2%.¹²



Liquen plano oral. Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

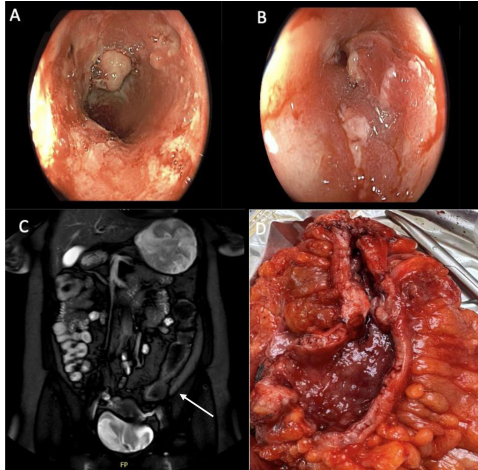
09 · GASTROENTEROLOGÍA

Enfermedad de Crohn

Mucosa «en empedrado» y queilitis granulomatosa

Entre el 0,5% y el 20% de los pacientes con enfermedad de Crohn presenta manifestaciones orales, a veces antes que los síntomas intestinales, lo que las convierte en un signo centinela valioso para el diagnóstico precoz.¹³ Las más características son el edema difuso de la mucosa con aspecto de «empedrado» (cobblestoning), úlceras lineales profundas en los surcos vestibulares, hinchazón labial persistente por infiltración granulomatosa (queilitis granulomatosa) y una mucogingivitis localizada en forma de «encía en fresa» (strawberry gums).

El hallazgo histológico distintivo, cuando se biopsia, es el granuloma no caseificante, idéntico al que aparece en las lesiones intestinales.¹⁶



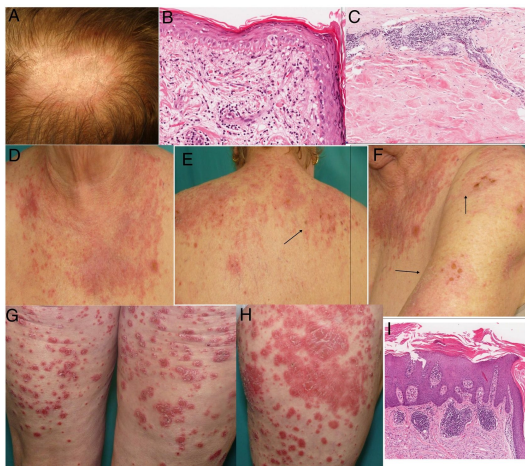
Manifestaciones orales de la enfermedad de Crohn. Fuente: Elsevier España; imagen original reproducida para fines educativos y de cita.

10 · AUTOINMUNE · REUMATOLOGÍA

Lupus eritematoso sistémico

Úlceras orales y placas discoides

Una revisión sistemática de 2022 que analizó 15 estudios encontró que las manifestaciones orales más frecuentes en el lupus eritematoso sistémico son las úlceras orales (a menudo indoloras, en paladar duro), la hiposalivación, las pigmentaciones, el ardor lingual (glosodinia), la lengua fisurada, la queilitis y, en algunos pacientes, un síndrome de Sjögren secundario asociado.¹⁴ Las lesiones específicas suelen presentarse como placas discoides de bordes blancos irradiados en forma de estrías («en panal de abeja» o honeycomb plaques) sobre una base eritematosa central, y son consideradas uno de los once criterios clínicos clásicos para el diagnóstico de la enfermedad.¹⁷



Lesión oral discoide en un paciente con lupus eritematoso sistémico. Fuente: Elsevier España, Reumatología Clínica; imagen original reproducida con fines educativos y de cita.

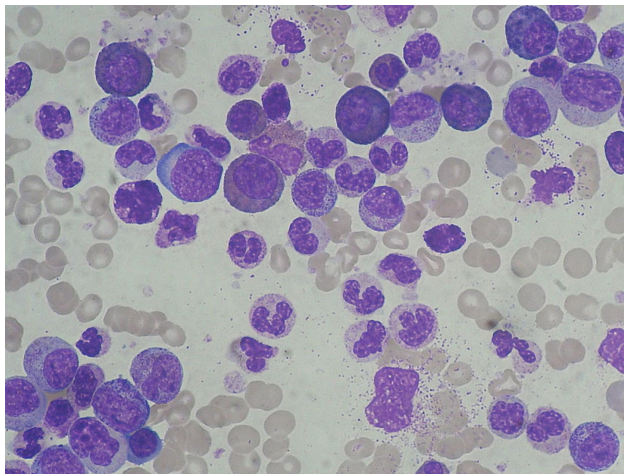
11 · HEMATOLOGÍA · ONCOLOGÍA

Leucemia

Hiperplasia gingival, petequias y ulceración

Hasta un 66% de los casos del subtipo de leucemia mieloide aguda monocítica (M5) presenta infiltración leucémica de la encía, que se manifiesta como un agrandamiento gingival difuso, edematoso y a menudo hemorrágico.

En series clínicas, las petequias o el sangrado (56%), la ulceración (53%) y el agrandamiento gingival (36%) figuran entre los signos orales iniciales más frecuentes de la enfermedad, y en ocasiones son el único motivo de consulta que conduce al diagnóstico.¹⁵ La palidez de la mucosa por anemia asociada y la mayor tendencia al sangrado gingival espontáneo, secundaria a trombocitopenia, completan el cuadro oral típico de estos pacientes.¹⁸



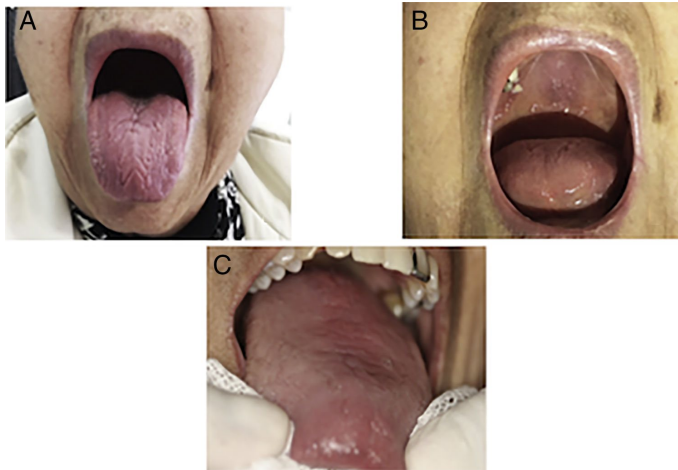
Leucemia: manifestaciones hematológicas relacionadas con el cuadro clínico oral. Fuente: El Español — Ciencia y Salud; imagen original reproducida con fines educativos y de cita.

12 · AUTOINMUNE

Síndrome de Sjögren

Xerostomía y aumento de caries

La destrucción autoinmune progresiva de las glándulas salivales produce una sequedad bucal marcada (xerostomía) que, al reducir el efecto protector y remineralizante de la saliva, se traduce clínicamente en caries cervicales de rápida progresión, fisuras y atrofia de la mucosa lingual, dificultad para hablar y tragar, y mayor susceptibilidad a la candidiasis oral.³ En la exploración es frecuente observar una mucosa seca, brillante y adherente al espejo dental, una lengua depapilada y, en las glándulas salivales mayores, episodios recurrentes de tumefacción parotídea.¹⁹



Xerostomía y afectación de la mucosa oral en el síndrome de Sjögren. Fuente: Elsevier España, Reumatología Clínica; imagen original reproducida con fines educativos y de cita.

En síntesis

Los casos reunidos aquí comparten un mismo mensaje clínico: la boca no es un compartimento aislado, sino un tejido tan vascularizado, innervado e inmunológicamente activo como cualquier otro órgano, y por eso refleja con rapidez lo que ocurre en el resto del cuerpo.

Una pigmentación nueva, una úlcera que no cicatriza, una encía que sangra sin motivo aparente o una lengua que cambia de aspecto no siempre son «solo» un problema dental: en ocasiones son la primera pista visible de una enfermedad sistémica que todavía no ha dado la cara en ningún otro lugar.

Nota importante. Este artículo tiene fines exclusivamente educativos y de divulgación. No sustituye una consulta odontológica o médica. Ante cualquier lesión, mancha o cambio persistente en la mucosa oral, la recomendación siempre es acudir a un profesional de la salud para su evaluación.

Referencias

1. Porter, S., Mercadante, V., & Fedele, S. (2017). Oral manifestations of systemic disease. *British Dental Journal*, 223, 683–691. doi:10.1038/sj.bdj.2017.884
2. Geographic Tongue. StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing.
3. American Academy of Family Physicians. Oral Manifestations of Systemic Disease. *American Family Physician*, 2010.
4. Angular cheilitis induced by iron deficiency anemia. *Cleveland Clinic Journal of Medicine*, 85(8), 581, 2018.
5. Sarkar, S. B., Sarkar, S., Ghosh, S., & Bandyopadhyay, S. (2012). Addison's disease. *Contemporary Clinical Dentistry*, 3(4), 484–486. doi:10.4103/0976-237X.107450.
6. Oral hyperpigmentation with weakness and salt-craving. *Cleveland Clinic Journal of Medicine*, 89(4), 180, 2022.
7. Peutz-Jeghers Syndrome. StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing.
8. Peutz-Jeghers syndrome. LITFL Medical Eponym Library.
9. Shimizu, A., Ebara, Y., Nomura, S., & Yamada, Y. (2020). Chronological changes in strawberry tongue in toxic shock syndrome toxin-1-mediated exanthematous disease. *Journal of General and Family Medicine*, 21(6), 280–281.
10. Oral manifestations of systemic disease. *BDJ Team*, 5, 18012, 2018.
11. Oral Candidiasis. StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing.
12. Hairy leukoplakia — Background y fisiopatología. Medscape / eMedicine.
13. Oral Lichen Planus: A Narrative Review Navigating Etiologies, Clinical Manifestations, Diagnostics, and Therapeutic Approaches. *Journal of Clinical Medicine*, 13(17), 5280, 2024.

14. Oral Manifestations of Systemic Disease. American Family Physician, 2010 (hallazgos en enfermedad de Crohn).
15. García-Ríos, P., Pecci-Lloret, M. P., & Oñate-Sánchez, R. E. (2022). Oral Manifestations of Systemic Lupus Erythematosus: A Systematic Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(19), 11910. doi:10.3390/ijerph191911910.
16. Leukemic gingival enlargement: A case report and review of literature. *Journal of Oral and Maxillofacial Pathology*, 22(Suppl 1), S77-S81, 2018. · Gingival Enlargement Can Constitute the Only Diagnostic Sign of Leukemia. *Cureus*, 2023.
17. Oral and Maxillo-Facial Manifestations of Systemic Diseases: An Overview. PMC8002330.
18. Lesiones orales para el diagnóstico de la enfermedad de Crohn: presentación de 5 pacientes. *Quintessence*.
19. Manifestaciones cutáneas y orales del lupus eritematoso sistémico. *Reumatología Clínica*, Elsevier España.
20. Leucemia: signos, síntomas y manifestaciones clínicas. *El Español — Ciencia y Salud*.
21. Manifestaciones bucales del síndrome de Sjögren. *Reumatología Clínica*, Elsevier España.
22. Las fotografías de las secciones 1 a 8 provienen de Wikimedia Commons (imágenes de dominio público de los CDC o publicadas bajo licencias Creative Commons CC BY / CC BY-SA por sus autores) y conservan su crédito y enlace de origen en cada pie de foto.

Créditos de imágenes. Las fotografías de las secciones 9, 10, 11 y 13 (Crohn, lupus, leucemia y Sjögren) proceden de Elsevier España y de El Español; son material con derechos reservados, reproducido aquí con fines exclusivamente educativos y de cita, con enlace a la fuente original en la publicación web.

Documento. Versión maquetada para lectura en formato PDF, basada en el contenido de la publicación web de referencia. Última actualización indicada en el sitio: agosto de 2026.